CÓDIGO 12 — CUIDADO COMUNITARIO, FRAGILIDADES FUNCIONALES Y SALUD COMUNITARIA

Versión: V1.6
Alineación declarada: Constitución V.35; Código 1 V1.10; Código 2 V1.7; Código 3 V1.8; Código 4 V1.9; Código 5 V1.6; Código 6 V1.8; Código 7 V1.9; Código 8 V1.6; C.1-Annex A V1.6; Código 9 V3.3; Código 10 V1.7; Código 11 V1.5; Código 13 V1.8; Código 14 V1.7; Código 15 V1.9; Código 16 V1.9.

Art. 1 — Objeto, definiciones y ámbito de competencia

1. El presente Código regula la organización del cuidado comunitario, la toma a cargo de las fragilidades funcionales, la gestión de los espacios y de los instrumentos de cuidado y la programación del tiempo necesario para garantizar las prestaciones esenciales. Estos recursos constituyen bienes comunes de infraestructura al servicio de la aplicación de la Cesta de Suficiencia, de la protección de la salud y del acceso a la vivienda.

2. A efectos del presente Código, se entiende por:

   a) **cuidado comunitario**: el conjunto de las actividades de apoyo a la vida cotidiana, relacional y doméstica, de acompañamiento, de apoyo educativo y de asistencia práctica que no constituyen prestaciones clínicas;

   b) **fragilidad funcional**: una condición temporal o permanente que limita la autonomía de la persona en el desempeño de una o más funciones esenciales comprendidas en los niveles 1 y 2 de la Cesta, con independencia de la presencia, la ausencia o la calificación de un diagnóstico clínico;

   c) **Cesta de Cuidado**: el componente de la Cesta de Suficiencia regulada por el Código 1 que comprende el tiempo mínimo de cuidado, el acceso a los espacios de cuidado y, cuando sea necesario, el apoyo en las comidas, en la higiene, en el acompañamiento y en el descanso protegido;

   d) **espacios de cuidado**: los espacios y las estructuras destinados, según las necesidades y la planificación territorial, a la cocina de apoyo a las personas frágiles, a la lavandería común, a la infancia de cero a tres años, al descanso protegido, a la asistencia de proximidad no clínica y a la acogida temporal comunitaria;

   e) **plan individual de cuidado**: el documento reservado que, sobre la base de la necesidad funcional comprobada y respetando la voluntad de la persona, determina las prestaciones necesarias, los sujetos responsables, la duración prevista y las fechas o condiciones de reexamen;

   f) **Ficha de Seguridad de cuidado**: el documento operativo que determina los riesgos relacionados con una actividad de cuidado concreta y establece las medidas preventivas, las competencias requeridas, los procedimientos de interrupción y las modalidades de sustitución en caso de indisponibilidad de un recurso esencial;

   g) **STV Cuidado**: la Ficha Técnica de Validación, adoptada según el artículo 3-bis del Código 2, que define los estándares, las cantidades mínimas, los procedimientos y las modalidades operativas de los servicios regulados por el presente Código.

3. Son bienes comunes de infraestructura inalienables:

   a) el tiempo mínimo de cuidado necesario para garantizar los niveles 1 y 2 de la Cesta;

   b) los espacios de cuidado esenciales del Círculo 1 y sus dotaciones comunes;

   c) el inventario de las ayudas técnicas básicas y del material asistencial no clínico destinados al cuidado comunitario;

   d) los conocimientos esenciales de cuidado y sus STV y Fichas de Seguridad;

   e) el balance agregado del tiempo de cuidado.

   La gestión de estos bienes no puede conllevar apropiación exclusiva, renta ni exclusión injustificada de las personas con derecho.

4. El Código 12 regula con carácter exclusivo, en el ámbito de su materia, la organización del cuidado comunitario, la comprobación de la fragilidad funcional, la Cesta de Cuidado, el tiempo de cuidado y la

función interna de los espacios de cuidado. Quedan atribuidos:

a) al Código 6 el diagnóstico, las prestaciones clínicas, la nutrición clínica y los demás actos sanitarios;

b) al Código 9 la producción y la preparación de los alimentos y la gestión técnico-organizativa de los comedores colectivos;

c) al Código C.1-Annex A la fabricación y la normalización de las ayudas técnicas;

d) al Código 10 el destino de uso y la localización territorial de los espacios;

e) a los Códigos 1, 4 y 14, cada uno en su materia, las disposiciones generales sobre la Cesta, sobre las garantías y sobre la seguridad.

5. El presente Código persigue los siguientes objetivos:

a) garantizar la continuidad de los niveles 1 y 2 de la Cesta también en presencia de fragilidad funcional;

b) impedir la formación de rentas sobre las prestaciones esenciales de cuidado;

c) asegurar una distribución equitativa, verificable y sostenible del tiempo de cuidado;

d) prevenir el aislamiento y el recurso injustificado a formas de institucionalización;

e) promover, cuando sea apropiado y la persona lo desee, la recuperación o el mantenimiento de la autonomía.

Art. 2 — Principios del cuidado comunitario

1. **Universalidad.** Toda persona tiene derecho a las prestaciones esenciales de la Cesta de Cuidado correspondientes a los niveles 1 y 2, sin supeditación a la contribución individual a la CBO y según las garantías previstas en el Código 1.
2. **Autonomía de la fragilidad funcional.** La fragilidad funcional constituye una condición relevante a efectos del cuidado comunitario, distinta del diagnóstico clínico. Su comprobación no requiere, por sí misma, una valoración sanitaria. Los actos clínicos siguen regulados por el Código 6.
3. **Proximidad y continuidad.** El cuidado esencial se organiza, en la medida de lo posible, dentro del Círculo 1. Las prestaciones que requieren competencias o estructuras no disponibles localmente se garantizan mediante la red federada a que se refiere el artículo 6.
4. **Prioridades y escasez.** Las prioridades generales de la Cesta son las establecidas en el Código 1, artículo 32. En caso de insuficiencia del tiempo de cuidado, la reducción afecta en primer lugar a las actividades del último nivel de la secuencia del artículo 4, apartado 7, y avanza hacia los niveles superiores, respetando la jerarquía del Código 1 y sin perjudicar las prestaciones esenciales de los niveles 1 y 2. Dentro de las prioridades aplicables, las decisiones tienen en cuenta la urgencia, la gravedad de la necesidad y el riesgo de interrupción del cuidado.
5. **No acumulación y no monetización.** El tiempo esencial de cuidado no puede monetizarse ni acumularse individualmente en una medida que reste disponibilidad a las demás personas con derecho. El eventual límite técnico de acumulación se define mediante una STV, sobre la base de la capacidad efectiva del servicio y con criterios públicos.
6. **Transparencia y confidencialidad.** Los inventarios de los espacios y de las dotaciones, así como los balances del tiempo de cuidado, se publican en forma agregada y no identificativa. Los datos individuales necesarios para la toma a cargo se tratan exclusivamente con esa finalidad, según el Código 7, artículo 2.2.
7. **Reversibilidad y reexamen.** Cuando la fragilidad es temporal, el plan individual de cuidado prevé, si es apropiado, un itinerario de apoyo a la autonomía y un plazo o una condición de reexamen. El reexamen no puede determinar la interrupción automática de las prestaciones esenciales sin una nueva valoración.
8. **Dignidad, voluntad y proporcionalidad.** Las prestaciones se organizan respetando la dignidad, las preferencias y la voluntad de la persona. Las limitaciones de la autonomía solo se admiten en los casos y con las garantías previstos por el ordenamiento aplicable y por los Códigos competentes.

Art. 3 — Consejo de Cuidado

1. Cada Círculo 1 constituye un Consejo de Cuidado compuesto por tres a cinco miembros, sorteados según el artículo 12-bis del Código 3. La composición asegura competencias adecuadas, al menos de nivel L2 o L3, en el ámbito del cuidado comunitario, del apoyo a la infancia de cero a tres años, de la edad avanzada, de la discapacidad y de la organización de los servicios de proximidad.
2. Los integrantes se sortean según el artículo 12-bis del Código 3, permanecen en el cargo un año y no pueden ser sorteados de nuevo en el mismo Consejo antes de doce meses desde el final del mandato. La sustitución, la declaración de los conflictos de intereses y el levantamiento de acta de las decisiones siguen los procedimientos del Código 3.
3. El Consejo de Cuidado:

   a) propone y aplica la Cesta de Cuidado y coordina los espacios de cuidado;

   b) elabora, actualiza y aplica las Fichas de Seguridad relativas a las actividades de cuidado, a la higiene, a la infancia y al acompañamiento;

   c) propone y actualiza las STV Cuidado según los procedimientos del Código 2;

   d) programa el balance agregado del tiempo de cuidado y coordina los turnos, respetando la libertad individual y las competencias de los participantes;

   e) organiza la formación de nivel L1 para el cuidado básico y de nivel L2 para las actividades especializadas previstas en el Código 5;

   f) alimenta el Registro de Dependencias regulado por el Código 15;

   g) coordina sus actividades con los Consejos de Salud, Agroecológico, de Hábitat, de Producción y de Biodiversidad, cada uno dentro de su competencia.
4. Los actos del Consejo de Cuidado se distinguen en:

   a) **actos técnicos reglados**, adoptados en aplicación de una STV o de una Ficha de Seguridad vigente;

   b) **propuestas y decisiones discrecionales**, adoptadas según el método del consenso y los procedimientos del Código 3, previa publicación durante al menos setenta y dos horas, salvo los casos de urgencia motivada.

   La publicación no comprende datos personales ni información que permita identificar a las personas atendidas.
5. Los dictámenes obligatorios de los Consejos competentes no transfieren la titularidad de la decisión. La decisión se adopta conjuntamente solo cuando un Código lo prevé expresamente.
6. Sin una Ficha de Seguridad vigente, la actividad afectada no puede iniciarse ni continuarse en las modalidades no evaluadas. El Consejo de Cuidado determina, cuando sea posible, una modalidad sustitutiva conforme que asegure la continuidad de los niveles 1 y 2. Toda excepción temporal se motiva, se limita a lo estrictamente necesario y se somete a verificación.

Art. 4 — Cesta de Cuidado y comprobación de la fragilidad funcional

1. La Cesta de Cuidado de los niveles 1 y 2 comprende, según la necesidad comprobada:

   a) el tiempo mínimo de cuidado;

   b) el apoyo durante la comida, cuando la persona no sea autónoma para alimentarse;

   c) la higiene asistida;

   d) el acompañamiento esencial;

   e) el descanso protegido;

   f) el acceso al espacio para la infancia de cero a tres años, cuando sea necesario.
2. La Cesta de Cuidado se cuantifica principalmente en horas de asistencia por persona y por semana. La STV Cesta de Cuidado define al menos las prestaciones comprendidas, los estándares mínimos, las

modalidades de distribución diaria, los criterios de urgencia, los tiempos de respuesta y los procedimientos de reexamen. Los estándares no pueden reducirse de modo que se comprometan los niveles 1 y 2 de la Cesta.

3. El aviso de una necesidad puede presentarlo la persona interesada o cualquier persona que detecte una necesidad de cuidado. El aviso:

   a) da inicio a la valoración funcional;

   b) permite, si existe una necesidad esencial, la activación provisional de las prestaciones necesarias durante un período máximo de setenta y dos horas, a la espera de la valoración;

   c) no puede utilizarse para iniciar tratamientos clínicos ni para atribuir un diagnóstico.

   Si existe un riesgo inmediato para la vida, la salud o la integridad de la persona, se activan sin demora los procedimientos de emergencia de los Códigos competentes.

4. El Consejo de Cuidado valora la condición funcional en un plazo de setenta y dos horas desde el aviso, sobre la base de criterios públicos contenidos en la STV. La intervención del Consejo de Salud solo se requiere cuando sean necesarias competencias sanitarias o cuando surjan aspectos de riesgo clínico. La valoración funcional no constituye un diagnóstico y no puede sustituir una comprobación sanitaria prevista en el Código 6.

5. El plan individual de cuidado indica al menos:

   a) la necesidad funcional detectada;

   b) las prestaciones y la frecuencia necesarias;

   c) la fecha de inicio y la duración prevista;

   d) la persona de referencia responsable de la coordinación;

   e) los plazos y los criterios de reexamen;

   f) las modalidades de continuidad o de sustitución en caso de indisponibilidad del servicio.

   La persona interesada participa en la definición del plan con las modalidades de comunicación y de apoyo apropiadas. Para una fragilidad temporal, el reexamen se realiza en un plazo de noventa días, salvo que sea necesario adelantarlo.

6. La lista mínima de las prestaciones de la Cesta de Cuidado la aprueba la Asamblea a propuesta del Consejo de Cuidado. Se requiere el dictamen obligatorio del Consejo de Salud limitado a los aspectos sanitarios. La lista, los estándares y los procedimientos se publican en la STV Cesta de Cuidado.

7. Las prioridades operativas se aplican respetando el Código 1, artículo 32, y según la siguiente secuencia de niveles, que se valora en relación con la urgencia y la necesidad individual:

   a) nivel 1: supervivencia, higiene esencial y descanso protegido;

   b) nivel 2: cuidado de la infancia de cero a tres años y apoyo a las personas de edad avanzada en situación de dependencia;

   c) nivel 3: convalecencia y período posterior al parto;

   d) nivel 4: apoyo al mantenimiento o a la recuperación de la autonomía;

   e) nivel 5: otras prestaciones de cuidado.

Art. 5 — Servicios, tiempo de cuidado y coordinación con los demás Códigos

1. Cada Círculo 1 asegura el acceso efectivo a los siguientes servicios básicos, directamente o mediante una red compartida:

   a) cocina de apoyo a las personas frágiles, coordinada funcionalmente con los comedores del Código 9;

   b) lavandería común;

   c) espacio para la infancia de cero a tres años;

   d) espacio de descanso protegido;

   e) acompañamiento de proximidad.

Las modalidades de prestación se definen de modo que se garanticen la accesibilidad, la continuidad y la seguridad.

2. El Círculo 1 es responsable, de forma colectiva, de la disponibilidad de la bolsa de horas necesaria para garantizar los niveles 1 y 2. La participación individual se produce según la disponibilidad, las competencias y las reglas del Código 3. No se admiten imposiciones incompatibles con la libertad individual, con las condiciones de la persona o con las competencias requeridas. La falta de disponibilidad individual no puede conllevar la pérdida del derecho de la persona frágil a las prestaciones esenciales.
3. El tiempo de cuidado se registra en forma agregada para programar los servicios, verificar la cobertura de los niveles 1 y 2 y detectar carencias. El registro no puede emplearse para elaborar perfiles de las personas que reciben o prestan cuidado fuera de las finalidades permitidas por el Código 7.
4. Las competencias se reparten del modo siguiente:

   a) el Código C.1-Annex A regula la fabricación, la reparación y la normalización de las ayudas técnicas;

   b) el Código 9 regula la producción y la preparación de los alimentos y la gestión técnico-organizativa de los comedores;

   c) el Código 12 regula la asistencia a la persona frágil en el acceso y el acompañamiento a la comida, en el consumo asistido, en la higiene y en el uso cotidiano de las ayudas técnicas.

   El presente Código no atribuye al Consejo de Cuidado la competencia para producir ayudas técnicas ni para organizar la preparación de los alimentos.
5. Para las prestaciones de nivel 4 o 5, antes de solicitar nuevos recursos se verifica la posibilidad de reutilización o recuperación de ayudas técnicas, ropa y espacios, siempre que la solución sea segura, adecuada a la necesidad y no reduzca la calidad de las prestaciones esenciales.
6. Se garantiza el derecho a permanecer en el propio domicilio de las personas mayores y en situación de dependencia, con apoyo comunitario por turnos incluido en la CBO, conforme al artículo 27 de la Constitución. Las Casas Comunes autogestionadas son una opción de la persona y no pueden constituir un destino forzoso.

Art. 6 — Espacios, red federada y territorio

1. Cada Círculo 1 activa y mantiene los espacios de cuidado necesarios, directamente o mediante acuerdos de red. Los espacios son accesibles, pueden dividirse en áreas funcionales y disponen de Fichas de Seguridad actualizadas para las actividades que efectivamente se realizan.
2. El destino de uso y la localización de los espacios los regula el Código 10. El Código 12 regula la función de cuidado que se desarrolla en su interior, sin modificar el destino territorial ni las restricciones de competencia del Código 10.
3. La Confederación asegura en cada Círculo 2 al menos una estructura federada con competencias avanzadas por cada tres o cuatro Círculos 1 que lo componen. La planificación, deliberada por la Asamblea General del Círculo 2, determina los servicios disponibles y las modalidades de acceso. Las estructuras garantizan, según las necesidades, competencias de pediatría social, apoyo a la discapacidad compleja y espacios temporales de emergencia.
4. El acceso a las estructuras federadas se produce según criterios públicos, no discriminatorios y compatibles con la urgencia de la necesidad. El inventario de los recursos se comparte entre los Círculos interesados y se actualiza con las modalidades establecidas por la STV.
5. La medición de los servicios se limita a los datos necesarios para la seguridad, la programación del tiempo de cuidado y la verificación de la Cesta de Cuidado. Los datos individuales eventualmente necesarios para la toma a cargo siguen siendo reservados; los indicadores públicos son agregados y no permiten la elaboración de perfiles. Se prohíbe la elaboración de perfiles de comportamiento individuales no necesaria para las finalidades del presente Código, de conformidad con el Código 7, artículo 2.2.

Art. 7 — Seguridad, formación y derecho de interrupción

1. Ninguna actividad dirigida a personas frágiles puede iniciarse sin una Ficha de Seguridad vigente y adecuada a la actividad. La Ficha la valida el Consejo de Cuidado, previo dictamen obligatorio del Consejo de Salud para los aspectos relativos al riesgo sanitario, la higiene y las comidas asistidas. La titularidad de la validación corresponde al Consejo de Cuidado, salvo los casos en que un Código prevea expresamente una validación conjunta.
2. Las Fichas de Seguridad de cuidado se coordinan con las disposiciones del Código 1, artículo 27, y del Código 14, cada uno según su competencia. En caso de riesgo sanitario o clínico se aplican los procedimientos del Código 6.
3. El material asistencial esencial para el cuidado comunitario se gestiona en el Almacén de Salud regulado por el Código 6. Está disponible sin costo para la persona interesada, se somete a mantenimiento y se registra en el inventario correspondiente. La indisponibilidad de un material asistencial esencial conlleva la suspensión únicamente de la actividad que no puede realizarse con seguridad; el Consejo de Cuidado activa, cuando sea técnicamente posible, una función sustitutiva conforme para asegurar la continuidad de los niveles 1 y 2.
4. La formación mínima requerida es la siguiente:

   a) nivel L1 para el acceso operativo a los espacios para personas frágiles y para las actividades de cuidado básico;

   b) nivel L2 para las actividades que implican a la infancia, a las personas de edad avanzada en situación de dependencia o a las personas con discapacidad, según la clasificación del Código 5;

   c) nivel L3 para el diseño de las actividades de cuidado, la elaboración de las STV y las funciones de validación previstas en el presente Código.
5. Cualquier persona que detecte un riesgo inmediato para una persona frágil interrumpe la actividad afectada, adopta las medidas urgentes de protección permitidas e informa sin demora al Consejo de Cuidado y a los demás Consejos competentes. La interrupción realizada de buena fe para prevenir un daño no puede conllevar represalias ni perjuicios para la persona autora del aviso.

Art. 7-bis — Protección de los menores y de las personas temporalmente incapaces

1. En caso de violencia, negligencia grave o perjuicio en daño de un menor o de una persona que no está en condiciones de protegerse, el Consejo de Cuidado abre sin demora un itinerario de protección, conforme al artículo 26.3 de la Constitución. El itinerario comprende la puesta en seguridad, la escucha y, si es necesario, la acogida temporal con personas de confianza o en un espacio protegido.
2. El hecho se comunica al Círculo de Garantía para los procedimientos del Código 4. Los avisos en la Red se limitan a la información necesaria para la protección. Durante la transición se aplica el artículo 37 del Código 4.
3. La separación de un menor de su Círculo 0 solo se admite como medida temporal de protección, cuando el menor no puede ser puesto en seguridad permaneciendo en el Círculo 0. La dispone:

   a) si existe un peligro inmediato, conforme al artículo 34, apartado 1, del Código 4;

   b) en los demás casos de violencia, negligencia grave o perjuicio, el Círculo de Garantía a propuesta motivada del Consejo de Cuidado, después de haber escuchado al menor y, salvo que ello lo exponga a peligro, a las personas que tienen la responsabilidad de su cuidado.

La separación se comunica sin demora al Tribunal de Garantía, que la convalida, la modifica o la revoca en un plazo de veinticuatro horas; a falta de convalidación, cesa. El menor es acogido, si es posible, por personas de su confianza. La convalidación indica quién toma, durante la separación, las decisiones cotidianas y presta el consentimiento a la atención sanitaria conforme al artículo 2-ter del Código 6. La separación convalidada dura hasta la decisión del apartado 3-bis y cesa con ella. No se aplica el artículo 34, apartado 3, del Código 4.

3-bis. En un plazo de treinta días desde la convalidación, el Tribunal de Garantía adopta la decisión estable sobre la guarda, después de haber escuchado al menor, asistido por la persona de confianza prevista en el artículo 31.5 de la Constitución, a las personas que tienen la responsabilidad de su cuidado, con las garantías del artículo 25, apartado 4, del Código 4, y al Consejo de Cuidado. El plazo puede prorrogarse una sola vez, por no más de otros treinta días, con decisión motivada, cuando un elemento necesario no puede obtenerse antes, como una valoración sanitaria del menor. Al vencimiento, el Tribunal decide con lo que consta en el expediente; si no se adopta la decisión, la separación cesa. Teniendo en cuenta la voluntad del menor según su edad y su madurez, dispone:

a) el regreso al Círculo 0, en su caso con un itinerario de apoyo; o bien

b) solo cuando el regreso expondría al menor a violencia, negligencia grave o perjuicio que un itinerario de apoyo no puede evitar, la guarda por personas que asumen la responsabilidad de su cuidado conforme al artículo 24.3 de la Constitución, indicando si esa responsabilidad sigue compartida con las personas que la ejercían o queda suspendida para ellas, y cómo se mantienen las relaciones con ellas, salvo que ello perjudique al menor.

El Tribunal reexamina la decisión al menos cada seis meses y en cualquier momento a petición del menor o de las personas que tenían la responsabilidad de su cuidado. Contra ella cabe el reexamen del artículo 35, apartado 2, del Código 4. El presente apartado se aplica también a la decisión sobre dónde y con quién viven los hijos menores de la persona que cesa de ser miembro conforme al artículo 29, apartado 6-bis, del Código 4; la decisión se adopta antes de que el cese produzca efectos y no requiere la separación del apartado 3. En ese caso, el cese no constituye, por sí solo, violencia, negligencia grave o perjuicio en el sentido de la letra b), y el Tribunal puede disponer también que el menor viva con la persona en la porción asignada, con la vivienda, la Cesta y los servicios que le corresponden como miembro.

3-ter. Durante la transición, la separación contra la voluntad de quien tiene la responsabilidad del cuidado y las decisiones del apartado 3-bis corresponden a las autoridades competentes del Estado, conforme al artículo 37 del Código 4. El Consejo de Cuidado comunica el caso, apoya al menor y colabora en su acogida.

4. Toda persona puede designar con antelación un representante para el caso de incapacidad, también mediante el documento de voluntades anticipadas previsto en el artículo 8-bis del Código 6.

5. A falta de designación y en caso de urgencia, el Círculo de Garantía nombra en un plazo de veinticuatro horas un representante temporal, elegido por este orden entre las personas del Círculo 0 indicadas por la persona, su persona de confianza y una persona sorteada con competencia L2 en el cuidado, sin conflictos de intereses. El cargo dura no más de treinta días y es renovable con decisión motivada hasta el nombramiento del representante estable previsto en el artículo 2-ter, apartado 5, del Código 6, que el Círculo de Garantía solicita al Tribunal de Garantía cuando la incapacidad dura o se prevé que dure más de sesenta días.

6. El representante decide según la voluntad expresada o presumible de la persona y, en su defecto, según su mejor interés. El cargo cesa cuando la persona recupera la capacidad.

Art. 7-ter — Elección de residencia y salida de los menores de la Confederación

1. En aplicación del artículo 26.2 de la Constitución, el menor que ha cumplido catorce años y ha alcanzado la autonomía puede elegir vivir en un Círculo 0 distinto del de las personas que tienen la responsabilidad de su cuidado, en la misma Comunidad o en otra, con el consentimiento de quienes viven allí, o en una vivienda asignada conforme al artículo 47-ter del Código 1. La elección no modifica la condición de miembro ni los derechos del artículo 26 de la Constitución. El menor puede en cualquier momento volver a vivir con las personas que tienen la responsabilidad de su cuidado.

2. La autonomía la valoran conjuntamente el Consejo de Cuidado y el Consejo de las Competencias, a petición del menor. En un plazo de treinta días desde la solicitud escuchan al menor, asistido, si lo desea, por la persona de confianza prevista en el artículo 31.5 de la Constitución, a las personas que tienen la responsabilidad de su cuidado y a quien lo acoge, y verifican:

a) que la elección sea libre, estable y no esté determinada por presiones de otras personas;

b) que el menor esté en condiciones de atender su vida cotidiana con el apoyo disponible;

c) que la nueva ubicación sea segura y le asegure la vivienda, la Cesta, la atención sanitaria, el aprendizaje y las relaciones con sus seres queridos.

La decisión es motivada e indica quién toma las decisiones cotidianas y cómo se mantienen las relaciones con las personas que tienen la responsabilidad de su cuidado, salvo que ello perjudique al menor. La responsabilidad del cuidado y el consentimiento a la atención sanitaria previsto en el artículo 2-ter del Código 6 siguen correspondiendo a quien los ejerce, salvo una decisión del Tribunal de Garantía conforme al artículo 7-bis, apartado 3-bis.

3. La elección de residencia y la oposición de las personas que tienen la responsabilidad de su cuidado no constituyen, por sí solas, violencia, negligencia grave o perjuicio en el sentido del artículo 7-bis. Si la solicitud revela violencia, negligencia grave o perjuicio, el Consejo de Cuidado abre el itinerario de protección del artículo 7-bis, que prevalece sobre el procedimiento del presente artículo.

4. Contra la decisión del apartado 2, o si no se adopta en el plazo, el menor y cada persona que tiene la responsabilidad de su cuidado pueden recurrir en un plazo de catorce días ante el Tribunal de Garantía, que decide en un plazo de treinta días con las garantías del artículo 7-bis, apartado 3-bis, teniendo en cuenta la voluntad del menor según su edad y su madurez. Contra la decisión del Tribunal cabe el reexamen del artículo 35, apartado 2, del Código 4.

5. A partir de los dieciséis años cumplidos, el menor puede hacer por sí mismo la declaración del artículo 4.8 de la Constitución, conforme al artículo 26.5 de la Constitución. La declaración va precedida de una entrevista con el Consejo de Cuidado, en la que el menor puede hacerse asistir por la persona de confianza; el Consejo le informa de los efectos del artículo 4.8, de los derechos que conserva conforme al apartado 8, del Pacto de Convivencia Autónoma y de la readmisión, y verifica con él dónde y con quién vivirá. La entrevista tiene lugar en un plazo de catorce días desde la solicitud; transcurrido el plazo sin entrevista, la declaración puede hacerse de todos modos. Se informa a las personas que tienen la responsabilidad de su cuidado, salvo que ello exponga al menor a peligro. Si, antes de cumplir dieciocho años, el menor no está en condiciones de decidir, se aplica el apartado 6.

6. Hasta cumplir dieciséis años, la declaración del artículo 4.8 de la Constitución por el menor la hace quien tiene la responsabilidad de su cuidado, solo en interés del menor, después de haberlo informado y escuchado de forma adecuada a su edad; la opinión del menor tiene un peso creciente con la edad y la madurez, conforme al artículo 26.2 de la Constitución. Si las personas responsables son más de una, deciden de común acuerdo. La declaración que una persona hace por sí misma no se extiende a los menores de cuyo cuidado es responsable.

7. En un plazo de catorce días desde la declaración del apartado 5 o del apartado 6, pueden dirigirse al Tribunal de Garantía el menor, cada persona que tiene la responsabilidad de su cuidado o el Consejo de Cuidado. El Tribunal escucha al menor, asistido por la persona de confianza, y a las personas responsables, y decide en un plazo de treinta días:

   a) para la declaración del apartado 5, verifica únicamente que sea libre e informada y que el menor esté en condiciones de decidir, sin valorar su oportunidad; el recurso no suspende sus efectos;

   b) para la declaración del apartado 6, decide según el interés del menor, teniendo en cuenta su opinión; hasta la decisión, la declaración no produce efectos para el menor. Si el menor sigue siendo miembro, el Tribunal decide también dónde y con quién vive, conforme al artículo 7-bis, apartado 3-bis.

Contra la decisión cabe el reexamen del artículo 35, apartado 2, del Código 4.

8. El menor que ya no es miembro conserva en todo caso el agua potable, la atención de urgencia vital y la protección de los menores garantizadas por el artículo 1.3 de la Constitución, los derechos del artículo 26 de la Constitución a los que remite el artículo 4.9-bis, incluido el acceso a la atención sanitaria y al aprendizaje, y los demás derechos del artículo 4.9. Puede seguir viviendo en su Círculo 0, con el consentimiento de quienes viven allí, y puede solicitar en cualquier momento la readmisión conforme al artículo 4.8 de la Constitución.

9. Durante la transición, el presente artículo se aplica dentro de los límites permitidos por la ley vigente sobre la responsabilidad del cuidado y sobre la participación de los menores en las entidades, conforme al artículo 37 del Código 4. La elección de residencia contra la voluntad de quien tiene la responsabilidad del cuidado y las decisiones del Tribunal previstas en los apartados 4 y 7 corresponden a las autoridades competentes del Estado; el Consejo de Cuidado apoya al menor.

Art. 8 — Registro de Dependencias del cuidado

1. El Consejo de Cuidado alimenta el Registro de Dependencias regulado por el Código 15, indicando al menos:

   a) **dependencias materiales**, relativas a ayudas técnicas, material asistencial o espacios no disponibles en la Confederación, disponibles solo más allá del umbral temporal crítico definido en la STV o no sustituibles localmente;

   b) **dependencias de competencias**, relativas a competencias de nivel L2 o L3 no disponibles en la cuenca a que se refiere el artículo 6, apartado 3;

   c) **dependencias externas**, relativas a servicios de cuidado externos a la Confederación necesarios para garantizar la continuidad de los niveles 1 y 2.

2. Para cada dependencia crítica el Registro indica:

   a) el recurso o la competencia que falta;

   b) el servicio y los niveles de la Cesta afectados;

   c) el responsable del plan de reducción de la dependencia;

   d) las medidas temporales de continuidad y de mitigación del riesgo;

   e) el plazo final previsto para la superación de la dependencia o para una nueva valoración motivada.

3. El plan de salida debe prever un plazo final cierto. Si la superación no es técnicamente realizable en ese plazo, el Consejo de Cuidado propone una revisión motivada del plan y de las medidas de continuidad; la revisión no puede limitarse a prorrogar la dependencia sin indicar intervenciones y responsabilidades.

4. Cada año se realiza una auditoría federada sobre la autonomía del cuidado por integrantes L3 independientes, sorteados según el artículo 36 del Código 4. La auditoría valora también la cobertura efectiva de los niveles 1 y 2 y el respeto de la confidencialidad.

Art. 9 — Prohibiciones, garantías y remedios

1. Se prohíbe:

   a) obtener rentas sobre la Cesta de Cuidado de los niveles 1 y 2, sobre los espacios esenciales, sobre el tiempo mínimo de cuidado o sobre el material asistencial esencial;

   b) supeditar a pago o a licencia exclusiva el acceso a las STV que salvan vidas y a las Fichas de Seguridad;

   c) reservar con carácter exclusivo o acumular tiempo de cuidado, espacios o ayudas técnicas por encima de los límites técnicos, cuando ello reduzca la disponibilidad para otras personas con derecho;

   d) negar o suspender una prestación esencial de la Cesta de Cuidado como medida sancionadora;

   e) transferir a sujetos externos el control de los espacios de cuidado esenciales;

   f) utilizar datos sobre la fragilidad funcional para la elaboración de perfiles o con finalidades distintas de la toma a cargo y de las finalidades técnicas expresamente permitidas por el Código 7;

   g) disponer la institucionalización forzosa de una persona, salvo una ubicación temporal estrictamente necesaria ante un riesgo inmediato, adoptada en las condiciones y con las garantías del artículo 8, apartados 4 a 10, del Código 6; para los menores se aplica el artículo 7-bis, apartado 3. Los eventuales tratamientos sanitarios siguen regulados por el Código 6 y por sus garantías.

2. Las infracciones del apartado 1 constituyen infracciones sustanciales. La comprobación, las medidas

cautelares, la suspensión o la desactivación de la función y los remedios se adoptan según el Código 4. El Consejo de Cuidado documenta los hechos y activa los procedimientos previstos, sin sustituir a los órganos competentes para la comprobación o para la aplicación de los remedios.

3. La suspensión o la desactivación de una función no conforme no puede interrumpir las prestaciones de los niveles 1 y 2 cuando sea posible garantizarlas mediante una función sustitutiva técnicamente conforme. En caso de riesgo inmediato, se aplican las medidas urgentes previstas en los Códigos competentes, con la activación simultánea de la continuidad asistencial en la medida de lo posible.

4. La persona interesada o quien demuestre un interés calificado puede recurrir ante la Garantía según el Código 4, en un plazo de catorce días desde la comunicación de la decisión o desde el conocimiento efectivo de la infracción. El recurso puede referirse a vicios de procedimiento, manifiesta falta de razonabilidad técnica, discriminación o desproporción. El recurso no suspende automáticamente las medidas urgentes necesarias para prevenir un daño, salvo decisión distinta del órgano competente.

Art. 10 — Aplicación, coordinación y primacía

1. El presente Código se coordina, en sus respectivas materias, con:

   a) el Código 1, artículos 27 y 32, para las Fichas de Seguridad y el orden de prioridades de la Cesta;

   b) el Código 2, para las STV;

   c) el Código 3, para las deliberaciones y el método del consenso;

   d) el Código 4, para la Garantía y los remedios;

   e) el Código 5, para los niveles de competencia y la formación;

   f) el Código 6, para la salud, las prestaciones clínicas y el Almacén de Salud;

   g) el Código 7, artículo 2.2, para las reglas sobre la red y sobre los datos;

   h) el Código 8, para los recursos hídricos eventualmente necesarios para los espacios de cuidado;

   i) el Código C.1-Annex A, para las ayudas técnicas;

   j) el Código 9, para la producción alimentaria y los comedores;

   k) el Código 10, para el destino territorial de los espacios;

   l) los Códigos 13, 14 y 15, en sus respectivas materias, incluidos la biodiversidad, la seguridad y el Registro de Dependencias.

2. En un plazo de seis meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1:

   a) censa, con modalidades respetuosas de la confidencialidad, las necesidades funcionales relevantes para la continuidad de los niveles 1 y 2;

   b) censa los espacios de cuidado, las dotaciones y las disponibilidades de tiempo;

   c) activa la Cesta de Cuidado mínima mediante una STV provisional y Fichas de Seguridad mínimas.

3. En un plazo de doce meses desde la entrada en vigor, cada Círculo 1:

   a) constituye el Consejo de Cuidado;

   b) garantiza el acceso a los espacios de cuidado mínimos;

   c) activa el inventario federado de las ayudas técnicas;

   d) adopta las STV definitivas para los niveles 1 y 2;

   e) determina su nodo de la Red de Cuidado federada.

   En caso de superposiciones documentadas de las cargas transitorias relativas a los Códigos 9, 10 y 12, la Asamblea puede conceder una prórroga motivada, por un período no superior a seis meses. La prórroga indica las actividades aún por completar, los responsables y los plazos intermedios, y no puede suspender la garantía de los niveles 1 y 2.

4. Las funciones existentes que infrinjan el artículo 9 se someten sin demora a verificación según el Código 4. En un plazo de noventa días desde la entrada en vigor debe iniciarse, para cada función afectada, un itinerario documentado de adecuación o, si la adecuación es técnicamente imposible, el procedimiento

de desactivación previsto en el Código 4. El plan determina la función sustitutiva y un plazo final cierto. La desactivación de una función que garantiza los niveles 1 y 2 solo se produce después de la activación de la sustitución, salvo las medidas urgentes necesarias para hacer frente a un riesgo inmediato, adoptadas con las garantías del Código 4.

5. En caso de superposición normativa, cada Código prevalece únicamente en la materia que se le atribuye:

   a) el Código 12 para la organización del cuidado comunitario, la comprobación de la fragilidad funcional, la Cesta de Cuidado y la función interna de los espacios de cuidado;

   b) el Código 6 para el diagnóstico, las prestaciones clínicas, la nutrición clínica y los riesgos sanitarios;

   c) el Código 9 para la producción y la preparación de los alimentos y la gestión técnico-organizativa de los comedores;

   d) el Código 10 para el destino de uso y la localización territorial de los espacios;

   e) el Código C.1-Annex A para la fabricación y la normalización de las ayudas técnicas;

   f) el Código 14 para los aspectos de seguridad de su competencia.

   La primacía se limita al objeto específico y no conlleva la absorción de las competencias atribuidas a los demás Códigos. En caso de conflicto que no pueda resolverse mediante una interpretación coordinada, los órganos competentes definen una solución conjunta según los procedimientos del ordenamiento, asegurando entretanto las medidas de protección necesarias y la continuidad de los niveles 1 y 2.